

美時

(1795 TT, NT\$186.5, 增加持股)

重點摘要

1. 美時 1H26 合併營收 174.5 億元、調整後 EBITDA 63 億元，分別 YoY 84%、50%，同創歷史新高；2Q26 營運結構亦回到較正常水準。惟淨利與 EPS 仍受 Alvogen 併表後的美國高成本負債及併購融資壓抑。
2. 公司已取得海外可轉換公司債（ECB）核准，並洽談以亞洲低成本資金置換美國雙位數利率債務，目標 2026 年底前完成，降息效益預計自 2027 年完整反映。我們預期若置換如期落地，利息費用下降將成為 2027 年淨利與 EPS 回升的主要催化劑；時程遞延則是核心風險。
3. 產品面，Duloxetine 已於 7M26 在美上市；專案 A 取得法院有利判決、專案 B 無訴訟，兩者均待 FDA final approval；LP757 PDUFA 為 2026/12/23。135 項專案中 46 項已送件或核准，50 項預計於 2026-2028 年上市，81% 具市場獨占、有限競爭或首波上市等優勢。我們看好密集取證與上市可接續中期成長，但仍須以專案 A、B 與 LP757 結果驗證。

結論

我們看好美時由規模擴張轉向每股獲利改善，理由為營收與 EBITDA 創高、融資成本可下修，以及美國重點藥進入取證與上市階段。短期最重要的獲利轉折是 2026 年底前能否完成高成本債務置換，營運催化則聚焦專案 A、B 的 FDA final approval 與 LP757 於 2026/12/23 的 PDUFA。我們認為若融資重整與產品核准同步落地，2027 年將有機會由 EBITDA 成長進一步轉化為 EPS 改善；主要風險為債務置換或 FDA 審查時程遞延。

1H26 財務結果與 2Q26 動能

- 1H26 合併營收 174.5 億元，YoY 84%；調整後 EBITDA 63.0 億元，YoY 50%，營收、EBITDA 與毛利同步再創新高
- 淨利與 EPS 下滑，主因為收購 Alvogen 後將其帳務併表，以及公司層級為執行該併購舉借貸款使整體負債上升；利息支出增加最主要的來源是 Alvogen 在美國的既有負債利率偏高
- 公司自身與亞洲端的借款成本約為中個位數，美國端則為雙位數，差異來自美國資金成本本就高於亞洲，且 Alvogen 當初舉債時的市場時機不佳
- 2Q26 營收 88.1 億元，QoQ 2%；調整後 EBITDA 33.4 億元，QoQ 13%；調整後淨利 7.9 億元，調整後 EPS 3.04 元。公司認為 2Q26 的結構已回到較正常的水平

凱基投顧

陳宣甫
886.2.2181.8724
hsuan.chen@kgi.com

徐雋翔
886.2.2181.8745
kenny.ch.hsu@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

融資成本與資本結構調整

- 海外可轉換公司債（ECB）已取得核准但尚未執行，目前是公司手上可運用的一個選項
- 同時與多家銀行洽談方案，將美國成本較高的債務轉由亞洲成本低很多的資金償還置換；置換進行順利，目前為推進最深入的階段
- 目標在 2026 年底前把各項方案推進完成，使降息效益能在 2027 年整年度完整反映

研發與產品核准進展

- LP757（Cabozantinib）505(b)(2)已獲 US FDA 受理；申請過程中原廠可提出專利挑戰的 45 天期間已經過，原廠並未提出挑戰，PDUFA 目標審查完成日為 2026/12/23，公司對如期完成審查有信心
- Xofluza（Baloxavir Marboxil）錠劑取得美國 FDA 核准，為該藥首款學名藥。公司原有的流感用藥屬 Tamiflu 類型，確診後須連續服用 5-7 天完整療程，Xofluza 則為單次投藥即可
- Duloxetine 於 2Q26 取得美國核准、7M26 已上市，屬 CNS 領域，為公司對外提出的美國三支重要上市藥品之一
- VIZZ（Aceclidine）已於菲律賓送件，先前已在新加坡與泰國送件。該藥為 2025 年簽署引進的創新藥，每日點藥一次可維持約 8 小時不需配戴老花眼鏡；公司希望 2027-2028 年在有自有直銷團隊的市場（菲律賓、泰國、台灣、韓國）開始看到貢獻
- Nintedanib 在多個新地區上市，是 1H26 B2B 大幅成長的主因之一，其中又以 Nintedanib 的量體最大

韓國與東南亞的業務開發

- Uro-Vaxom 於 2026 年 5 月簽署收購韓國業務協議，7M26 已開始產品經銷，預計 4Q26 完成藥品許可證（MA）移轉並完成整個收購；MA 移轉後會陸續進行生產移轉，最終目標是直接在有自有的韓國藥廠生產，以提升該產品毛利率與整體效益
- SERPLUMA（serplulimab）在韓國原為孤兒藥，孤兒藥沒有其他競爭，但反面是用藥不普遍、用量不會太高；已取得韓國 MFDS 核准用於小細胞肺癌第一線治療，下一步是爭取納入韓國健保給付（reimbursement scheme）
- 菲律賓 Sandoz 業務於 7M26 完成收購並於當月首度併入營收；此案邏輯與 2024 年 8 月完成的泰國業務相同，大型藥廠在東南亞當地的團隊對其自身貢獻有限，但亞洲尤其東南亞對公司是非常重要的市場領域
- 泰國自建團隊後貢獻至今非常好，東南亞占公司整體的比重越來越高，菲律賓預期會是同一個故事
- 東南亞最大的幾個市場泰國、菲律賓、越南均已自有團隊；規模較小的馬來西亞、新加坡尚未建立、仍在觀察，若最終沒有取得，仍可維持以 partnership 或 distributor 方式銷售

現有產品線結構與競爭優勢分類

- 專科藥品產品線共 135 項專案，自行研發與外部引進約各占一半，目標市場規模達 1,250 億美元以上
- 預期上市時程分三段：近期 2026-2028 年 50 項、中期 2029-2031 年 49 項、長期 2032 年以後 36 項；分布均勻並以近期最多，2027-2028 年公司會把最多精力放在這批產品的送件、取證與上市準備
- 135 項中有 46 項（逾 1/3）已送件或已取得核准，屬上市準備的後期階段；其中部分即使已取得核准，仍須等待原廠專利等限制解除後才能上市
- 81%的專案在上市時具備競爭優勢，依競爭程度分四類，81%落在前三類：
 - 享有市場獨占期：first file 或 180 天 exclusivity，等於擁有獨有市場
 - 有限競爭：預估上市時含公司在內不超過 3 家競爭者，價格與毛利可維持相當可觀的水平
 - 首波上市：競爭者達 4-5 家並於同一期限內一起上市，回報不如前兩類但仍不錯
 - 第二波上市：較他人慢半年至一年才上市，數量不多、回報率較低但仍在預期內
- 市場布局以美國 63 項最多，因為美國單一國家就占全球藥品收入約 40%；亞洲以泰國、越南、台灣、菲律賓、韓國的專案數最多；日本共 4 項且其中 1 項已取得核准

高潛力產品線與美國三支重點藥

- 首次對外揭露高潛力專案清單，分 2026-2027 年與 2028-2030 年兩組、合計約 13-14 項；清單並非公司在此期間僅推出這些產品（單 2026-2028 年即有 50 款），而是內部認為最值得鼓舞的一批。上市時間為公司内部目前的評估，仍須視開發進度、審查進度與訴訟而定
- 2026-2027 年這一組全部已完成送件，處於上市前的最後一段步驟，中間仍須取得部分核准
- 專案 A（感染領域、美國）為腸躁症用藥。2026 年 8 月底法院作出對公司有利的判斷，認定原持有 180 天 exclusivity 的藥廠該項獨占已失效，案件退回並要求 FDA 重新檢視；若 FDA 複核後同意即可核發 final approval。公司期望 FDA 在 2026 年底前剩下的 4 個月內盡快核准
- 專案 B（呼吸道、美國）沒有任何訴訟在進行中，單純等待 FDA 核發 final approval 即可推出
- 專案 A、專案 B 加上 7M26 已上市的 Duloxetine，即為公司在 2026 年初對外提出的美國三支重點上市藥品目標，目前已推出 1 支、另 2 支等待 FDA 放行

- 專案 C（中樞神經科學名藥）：美國市場規模近 5 億美元，已送件並預計於 2027 年首波上市。
- 專案 D 及專案 E（中樞神經科 505(b)(2)新藥，bipolar）：以美國為目標市場，分別具備低價競爭力與市場獨佔期優勢，均已完成送件。
- 清單中規模最大的專案 F 約 200 億美元，將在美國、韓國與東南亞上市；距 2030 年僅剩約 4 年，這段期間內有十幾款可帶來較大貢獻的產品

QA

- 505(b)(2)專案中，「有限競爭」與「享有市場獨佔期」這兩種分類的差異為何？
 - 部分 505(b)(2)雖可當作新藥看待，但公司並不主張該藥優於原廠藥或 reference drug，定位與原產品相同、僅價格較便宜，這種情況不會取得 exclusivity，因此歸類為 limited competition
- 有限競爭這一類專案，能否提供目標市場規模？
 - 不揭露。這些藥仍在審查中且有 litigation 風險，若揭露市場規模，對手可能因此辨識出是哪一支藥
 - 製作該表時已盡量把透明度放到最大，但必須先確認揭露不會對將來推出這些產品造成風險
- LP757 屬癌症領域的 505(b)(2)，漢達預計近期取證，如何看待這支產品後續的市場競爭態勢？
 - 難以預估。不確定因素太多，公司自己何時能推出、對方何時推出都不確定，競爭狀況會持續變動
 - 該圖表是 2026 年 7 月底製作，採取的是較保守但務實的判斷
- 美國的銷售團隊規模有多大？其中專責 505(b)(2)的部分呢？
 - 銷售人員超過 90 人
 - 專責 505(b)(2)的團隊具體人數不清楚，需要再查
 - 公司會視情況在美國持續增聘銷售人員、擴大 505(b)(2)的銷售通路，因為產品線上已有數支這類產品
- 公司產品上市後，其他學名藥廠是否也會一併被解除限制而提前上市？
 - 不一定。部分學名藥廠與原廠簽有協議，已簽協議者不得提早把產品上市
- 專案 B 大約何時可以取證上市？
 - 仍期待落在 2026 年內，目前處於等待 FDA 核發 final approval 的階段
- 若專案 B 取證後市場上為兩家學名藥供應商，單一學名藥廠通常可取得多少市佔率？
 - 不好說，沒有通則，不同藥品之間差異可以很大，且該藥屬呼吸道用藥，難以用其他藥品類比

- 實際市佔取決於另外兩家的推出速度、價格，以及對方與公司各自的銷售分布
- 專案 B 若為第二家取證，第一家目前的市佔率是多少？
 - 公司不知道，會再查詢是否有相關資訊

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888 • 傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888 • 傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888 • 傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188 • 傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股(OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有(N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股(U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等(NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
未評等(R)	
*總報酬=(十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。